VIS PHARMA COMPASS

governance for hospital pharmacy spend

Il percorso dell'euro farmaceutico

Benefici organizzativi per tappa

Sintesi dei vantaggi gestionali, economici e di tempo professionale

Destinatario	[Direttore Generale / Direttore Sanitario / Direttore del Servizio Farmaceutico]
Ente	[Denominazione dell'Ente]
Fornitore	[Denominazione del Fornitore]
Data	[gg/mm/aaaa]
Oggetto	Definizione dei benefici attesi per tappa del ciclo di governo della spesa farmaceutica

Documento riservato. Le stime di tempo professionale sono ipotesi dichiarate, da validare sui volumi effettivi dell'Ente in fase di analisi diagnostica.

Indice

1 Premessa **1**
1.1 I due benefici che si misurano . . . 1
1.2 Volumi e parametri di riferimento . . . 1

2 Le sei tappe **2**

Tappa 0. Orizzonte **3**

Tappa 1. Programmazione **4**

Tappa 2. Acquisto **6**

Tappa 3. Custodia **8**

Tappa 4. Rendicontazione **9**

Tappa 5. Confronto e chiusura **11**

3 Una leva trasversale: il confronto normalizzato per attività **13**
3.1 Che cosa cambia aggiungendo il denominatore . . . 13
3.2 Che cosa emerge, su dati reali . . . 13
3.3 Impatto quantitativo . . . 14

4 Riepilogo dei benefici attesi **15**
4.1 Tempo professionale . . . 15
4.2 Valore economico . . . 16
4.3 Che cosa è cambiato dopo la revisione clinica . . . 16
4.4 Che cosa non è compreso nella stima . . . 17

5 Sintesi dell'impatto complessivo **17**
5.1 Le tre condizioni senza le quali nulla di tutto questo accade . . . 17

1 Premessa

Questo documento raccoglie, in forma sintetica e orientata al beneficio organizzativo, i vantaggi attesi dall'introduzione di VIS Pharma Compass presso l'Ente.
L'obiettivo non è descrivere la tecnologia in sé, ma rendere esplicito il **valore concreto** che ciascuna tappa porta al lavoro quotidiano della Direzione di Farmacia, al governo economico dell'Azienda e alla posizione dell'Ente rispetto alla Regione.

1.1 I due benefici che si misurano

Ogni tappa dichiara due grandezze distinte, che non vanno sommate né confuse.

Grandezza	Che cosa misura
Valore economico	L'opportunità già esistente sul perimetro, che lo strumento rende visibile e quantifica. Non è generata dallo strumento: è generata dalla scadenza brevettuale, dalla decisione clinica o dall'accordo negoziale. Lo strumento riduce il ritardo con cui l'Ente vi reagisce
Tempo professionale	Le ore che oggi la struttura spende in raccolta, riconciliazione e formattazione manuale del dato, e che tornano disponibili per l'attività di governo

Un avvertimento metodologico, dichiarato in apertura. Il valore economico è di gran lunga la grandezza più rilevante: sul perimetro di riferimento vale circa 649.000 euro all'anno contro i circa 18.000 euro di tempo professionale. Il tempo liberato è un beneficio reale e verificabile, ma non è l'argomento principale e non va usato come tale.

Questa versione recepisce una revisione clinica. Il documento è stato riletto da un direttore di farmacia ospedaliera. Quattro punti sono cambiati nella sostanza.

- Le stime di tempo professionale sono state giudicate plausibili e restano invariate.
- La perdita di esclusiva non equivale alla commercializzazione certa di un equivalente. La valorizzazione della tappa Acquisto ne tiene ora conto con un fattore esplicito.
- Il capitale immobilizzato in scorte è quantificabile con un riferimento operativo condiviso, riportato alla tappa Custodia.
- La tappa dedicata agli sprechi di allestimento oncologico è stata eliminata: i laboratori UFA centralizzati sono ormai diffusi in tutte le Aziende e la leva è in larga parte già esercitata.

1.2 Volumi e parametri di riferimento

Parametro	Valore	Origine
Aziende Sanitarie del perimetro	4	Dato reale, prototipo
Spesa farmaceutica annua del perimetro	452,7 mln €	Dato reale, prototipo
Record di erogazione elaborati	261.153	Dato reale, prototipo
Giornate/anno oggi dedicate alla produzione manuale del dato	108	Ipotesi, validata in revisione
Ore per giornata lavorativa	7	Convenzione
Costo orario di un dirigente farmacista, lordo Ente	45 €	Ipotesi convenzionale

Sulla natura delle stime di tempo. Le giornate indicate per ciascuna tappa sono ipotesi di lavoro costruite su una struttura di dimensione media, giudicate plausibili in sede di revisione clinica e da validare sui volumi effettivi dell'Ente durante l'analisi diagnostica. Sono dichiarate come tali anziché omesse, perché un ordine di grandezza esplicito e discutibile è più utile di un vuoto. Le percentuali di riduzione tengono conto del fatto che nessuna attività viene azzerata: l'estrazione dai sistemi sorgente, la validazione professionale del dato e la decisione restano a carico dell'Ente.

2 Le sei tappe

Il soggetto che si muove, in questo documento, è **l'euro farmaceutico**. Entra come budget assegnato, diventa contratto di gara, si trasforma in giacenza di magazzino, viene erogato come consumo, viene rendicontato in flussi e registri, e alla fine dell'esercizio o rientra sotto forma di recupero, oppure si perde. **Ogni tappa è un punto in cui il valore può disperdersi, e ogni modulo presidia una tappa precisa.** Il ciclo è chiuso: quanto si apprende alla tappa 5 alimenta la programmazione dell'esercizio successivo.



	Tappa	Modulo	Dove si perde valore oggi	Valore annuo
0	Orizzonte	M7	Il farmaco nuovo entra in prontuario senza che il suo impatto di budget sia stato stimato prima	non stimato
1	Programmazione	M1	Lo scostamento si scopre a consuntivo, quando l'esercizio è chiuso e non è più correggibile	205.000 €
2	Acquisto	M2	Mancata rinegoziazione o gara sui nuovi equivalenti, e ritardo nella contrattualizzazione dopo l'aggiudicazione	384.000 €
3	Custodia	M4	Capitale immobilizzato oltre il riferimento operativo, e prodotti che arrivano a scadenza	misurato, non sommato
4	Rendicontazione	M3	Erogazioni non registrate nei registri AIFA, quindi note di credito mai richieste	60.000 €
5	Confronto	M6	La variabilità fra Aziende resta invisibile, quindi non correggibile	abilitante
Totale quantificato, scenario prudenziale				**649.000 €**

Tappa 0. Orizzonte

Modulo M7. Orizzonte e simulazione di impatto

> **Fase del ciclo.** L'euro non è ancora stanziato. Un farmaco è in negoziazione presso AIFA o ha appena ricevuto un'opinione positiva CHMP, e produrrà un impatto di spesa che oggi nessuno ha ancora quantificato.

Il problema attuale

La Direzione di Farmacia viene a conoscenza dell'impatto economico di un nuovo farmaco quando la prima richiesta arriva dal reparto, cioè quando la decisione di budget è già stata presa altrove. La stima di impatto, quando viene richiesta dalla Direzione, si costruisce a mano, sotto pressione, su fonti eterogenee e con un margine di errore che nessuno è in grado di dichiarare.

Beneficio gestionale. Programmare anziché subire

Il modulo monitora le opinioni CHMP ed EMA, le negoziazioni AIFA in corso e i farmaci in attesa di classificazione, e produce per ciascuno una stima di impatto di budget **prima** dell'ingresso in prontuario.

- **Simulazione di coorte a livello aggregato.** A partire dalla numerosità attesa della popolazione trattabile sul perimetro e dal costo per ciclo, produce uno scenario di spesa incrementale a 12 e 24 mesi.
- **Anticipo della discussione di prontuario.** La Commissione Terapeutica riceve la valutazione economica insieme alla richiesta, anziché mesi dopo.
- **Coerenza con la programmazione regionale.** La stima è costruita sullo stesso perimetro e con le stesse unità di misura del cruscotto di spesa, quindi confrontabile con il budget assegnato.

Impatto quantitativo

- Attività oggi: ricerca informale sui farmaci in arrivo e stime di impatto su richiesta della Direzione, **6 giornate/anno**.
- Riduzione stimata: 65%, pari a **4 giornate/anno** liberate (28 ore).
- Valore economico: **non valorizzato in offerta.** Il beneficio è di natura programmatoria e si misura sulla qualità della previsione di budget, non su un risparmio diretto.

Limite. Il modulo lavora su numerosità attese e spesa aggregata. Non identifica pazienti eleggibili e non produce alcuna valutazione riferita a un individuo.

Tappa 1. Programmazione

Modulo M1. Cruscotto direzionale della spesa

Fase del ciclo. Il budget, o più spesso il tetto di spesa, è assegnato e l'esercizio è aperto. Da questo momento ogni mese che passa senza una lettura affidabile è un mese in cui lo scostamento cresce senza essere visto.

Il problema attuale

I dati esistono, ma vivono in flussi separati: consumo ospedaliero, distribuzione diretta, distribuzione per conto, File F. Metterli insieme richiede un lavoro manuale di riconciliazione che si ripete a ogni richiesta della Direzione. Il risultato arriva quando l'esercizio è già avanti, e la proiezione di fine anno, quando esiste, è un'estrapolazione lineare priva di presidio sulle voci che stanno effettivamente crescendo.

Beneficio gestionale. Decidere mentre l'esercizio è ancora aperto

Il modulo costruisce l'unica base dati riconciliata su cui poggiano tutti gli altri, e produce la lettura della spesa per Azienda, canale, ATC, principio attivo e specialità, con confronto su periodi omogenei.

- **Quadratura documentata.** I totali sono riconciliati con il bilancio e con i flussi già trasmessi alla Regione. Ogni scostamento è documentato prima di procedere, quindi il dato è difendibile in sede di controllo.
- **Concentrazione della spesa resa visibile.** Sul perimetro di riferimento le prime venti specialità assorbono il 28,5% della spesa. Presidiare quaranta voci significa presidiare oltre un terzo del totale.
- **Early warning sulle molecole in crescita anomala.** Il perimetro osservato contiene casi di crescita da zero a oltre 2,5 milioni di euro in una sola annualità. Intercettarli al terzo mese anziché a consuntivo è la differenza fra correggere e constatare. È un'evidenza immediata su cui intervenire, e va direttamente nelle mani del farmacista e della Direzione senza passaggi intermedi.
- **Proiezione di fine esercizio e alert di sforamento.** La traiettoria verso il superamento del tetto viene segnalata con mesi di anticipo. È il beneficio che la Direzione percepisce per primo, perché trasforma una previsione impressionistica in un numero difendibile mentre l'esercizio è ancora aperto.

Impatto quantitativo

- Attività oggi: reportistica direzionale di spesa (12 giornate) e analisi ad hoc su richiesta della Direzione (10 giornate), **22 giornate/anno**.
- Riduzione stimata: 64%, pari a **14 giornate/anno** liberate (98 ore).
- Valore economico: **205.000 €/anno**, da presidio delle molecole in incremento.

Come si arriva a 205.000 euro. La base non è la spesa complessiva ma il solo incremento: le prime venti specialità per crescita hanno prodotto 24,4 milioni di euro di spesa in più rispetto all'esercizio precedente. Su quell'incremento si applica un recupero dell'1,5%, che nasce da una verifica puntuale su tre punti: che il prodotto in crescita sia effettivamente coperto da un contratto aggiudicato, che la crescita corrisponda a un aumento di casistica e non a uno

scivolamento su una specialità più costosa a parità di molecola, e che l'incremento sia coerente con le indicazioni approvate. Non è un risparmio sulla spesa esistente, è il recupero di una quota della crescita non giustificata. L'1,5% è deliberatamente basso: significa intercettare poco più di una voce su settanta fra quelle in aumento.

Limite. Nessuna analisi per singolo paziente. Il livello minimo di aggregazione è la struttura erogante. La stima di 22 giornate/anno per questa tappa è stata giudicata plausibile in sede di revisione clinica.

Tappa 2. Acquisto

Modulo M2. Radar delle scadenze brevettuali e delle opportunità biosimilari

> **Fase del ciclo.** L'euro sta per essere impegnato. È il momento in cui una decisione sbagliata si cristallizza per l'intera durata del contratto, e in cui una decisione tempestiva vale per tutta la durata residua dell'esercizio.

Il problema attuale

Il calendario delle perdite di esclusiva è pubblico, ma non è incrociato con la spesa effettiva dell'Ente. Da qui nascono tre perdite distinte, che nella pratica si presentano insieme.

- **Mancata rinegoziazione o mancata gara sui nuovi equivalenti.** L'equivalente entra in commercio e la fornitura resta quella di prima, semplicemente perché nessuno ha collegato la data alla spesa.
- **Ritardo nella contrattualizzazione dopo l'aggiudicazione.** La gara si chiude ma il contratto non è ancora operativo, e nel frattempo si continua ad acquistare al prezzo precedente.
- **Rinnovo a prezzo pieno di un contratto pluriennale** su una molecola che perderà l'esclusiva pochi mesi dopo. Qui il differenziale diventa irrecuperabile fino alla scadenza contrattuale.

A questo si aggiunge un problema di visibilità: il report di spesa tradizionale aggrega per ATC e non distingue originator da biosimilare all'interno della stessa molecola, quindi la quota residua su originator resta invisibile.

Beneficio economico. La tappa a valore più immediato e causalmente più difendibile

Il modulo incrocia la spesa effettiva con il calendario delle perdite di esclusiva a 24 mesi e con la disponibilità effettiva di alternative genericate o biosimilari, e valorizza in euro il differenziale non colto.

- **Distinzione fra scadenza e commercializzazione.** Una perdita di esclusiva non equivale alla commercializzazione certa di un equivalente. Ogni voce riporta uno di tre stati: equivalente già in commercio, atteso, incerto. Solo il primo è una certezza, confermata dalle Liste di Trasparenza AIFA. La data stessa può spostarsi per certificati protettivi complementari, estensioni pediatriche o contenziosi, e su alcune molecole nessun produttore ha interesse a entrare.
- **Normalizzazione per milligrammo e per DDD.** Originator e biosimilare sono ricondotti a un'unità di confronto omogenea. Passaggio non eludibile: il confronto per confezione produce differenziali privi di significato.
- **Calendario delle gare da anticipare.** Le scadenze contrattuali dell'Ente sono allineate con le scadenze brevettuali, e i rinnovi a rischio sono segnalati con la finestra utile per intervenire.
- **Quota residua su originator, molecola per molecola.** Sul perimetro di riferimento sono emersi 13,6 milioni di euro ancora allocati sull'originator in molecole con penetrazione biosimilare sotto il 50%, di cui 8,0 milioni su tre molecole a penetrazione pari a zero.
- **Piano di azione ordinato per valore.** Ogni voce riporta molecola, Azienda, valore, finestra temporale utile e funzione responsabile, in un formato direttamente portabile in Commissione Terapeutica. Non serve soltanto a decidere l'acquisto: è il materiale con cui condividere con i clinici gli orientamenti prescrittivi dei mesi successivi, prima che la decisione diventi urgente.

Impatto quantitativo

- Attività oggi: istruttoria dei dati a supporto delle gare (8 giornate) e preparazione della Commissione Terapeutica (6 giornate), **14 giornate/anno**.
- Riduzione stimata: 50%, pari a **7 giornate/anno** liberate (49 ore).
- Valore economico: **384.000 €/anno**, così composto.
  - 240.000 € da anticipo della conversione dopo l'ingresso dell'equivalente. Base: 22,8 milioni di euro esposti a perdita di esclusiva entro 12 mesi, di cui il 60% su molecole per le quali un equivalente entra davvero in commercio, 35% contendibile nell'esercizio, differenziale 20%, anticipo di 90 giorni.
  - 144.000 € da recupero della quota su originator dove il biosimilare è già in commercio. Base: 13,6 milioni di euro, 50% switchabile, differenziale 25%, attribuzione allo strumento 30%.

Il fattore del 60% è la correzione più importante di questa versione. Nella versione precedente la leva valeva 400.000 euro perché assumeva implicitamente che a ogni scadenza corrispondesse un equivalente in commercio. Non è così, e la correzione costa 160.000 euro di stima. In compenso rende il numero difendibile davanti a un farmacista ospedaliero, che è esattamente l'interlocutore che lo verificherebbe per primo.
Nella direzione opposta, su perimetri più ampi o su Aziende con un arretrato di rinegoziazioni la stessa leva può valere alcuni milioni di euro: qui è calcolata su un perimetro specifico e con parametri deliberatamente bassi.

Limite. Lo strumento identifica l'opportunità e la quantifica. La valutazione di sostituibilità clinica resta interamente del farmacista e del clinico, ed è esercitata nei canali istituzionali già esistenti. La quota di penetrazione biosimilare non è comprimibile a zero: continuità terapeutica, pazienti già in trattamento e specifiche indicazioni cliniche costituiscono un limite fisiologico considerato dal parametro di switchabilità.

Tappa 3. Custodia

Modulo M4. Scorte, scadenze e carenze

> **Fase del ciclo.** L'euro è già stato speso e ora è fermo in magazzino sotto forma di giacenza. Da questo momento perde valore ogni giorno: per obsolescenza, per scadenza, o semplicemente perché è capitale immobilizzato.

Il problema attuale

Il controllo delle scadenze è tipicamente reattivo: si interviene quando il prodotto è ormai prossimo al termine e la redistribuzione non è più praticabile. La visibilità sulle giacenze delle altre strutture dell'Ente, o delle altre Aziende del perimetro, è nella maggior parte dei casi assente, quindi un prodotto in scadenza in una sede e in carenza in un'altra resta un'occasione mancata su entrambi i lati.

Beneficio economico e operativo. Capitale immobilizzato e valore a rischio

Il modulo misura il capitale immobilizzato in scorte, il valore a rischio di deterioramento a scadenza e l'esposizione alle carenze dichiarate.

- **Valore a rischio a 30, 60 e 90 giorni.** La finestra di 90 giorni è quella in cui la redistribuzione è ancora possibile. Segnalare a 30 giorni significa segnalare troppo tardi.
- **Indice di rotazione e giacenze lente.** Identifica il capitale che sta fermo senza ragione operativa.
- **Proposte di redistribuzione ordinate per valore recuperabile**, fra strutture della stessa Azienda o del perimetro regionale.
- **Esposizione alle carenze dichiarate.** Incrocio con l'elenco nazionale dei farmaci temporaneamente carenti e valutazione di impatto sui consumi previsti.
- **Rendicontazione ambientale.** Valore e volume dei prodotti giunti a scadenza, in un formato utilizzabile nel bilancio di sostenibilità dell'Ente.

Impatto quantitativo

- Attività oggi: monitoraggio scorte, controllo scadenze e gestione delle redistribuzioni, **12 giornate/anno**.
- Riduzione stimata: 50%, pari a **6 giornate/anno** liberate (42 ore).
- Valore economico: **non valorizzato in offerta.** Il risparmio da minori scaduti e da minor capitale immobilizzato è un beneficio reale, ma si preferisce misurarlo sul perimetro dell'Ente durante il periodo di verifica anziché stimarlo in offerta.

> **Limite.** Il modulo non emette ordini e non movimenta stock: propone, non esegue.

Tappa 4. Rendicontazione

Modulo M3. Registri AIFA, File F e flussi

Fase del ciclo. L'euro è stato speso e ora deve essere rendicontato. È la tappa in cui l'Ente può recuperare denaro già dovuto, oppure perderlo per un adempimento non completato entro il termine utile.

Il problema attuale

È la tappa che assorbe più tempo professionale e che produce, quando fallisce, una perdita economica secca e non recuperabile. La coerenza fra consumo erogato, dato di File F e posizione nei registri di monitoraggio si verifica oggi con incroci manuali, spesso su fogli di calcolo. Un trattamento consumato ma non registrato, una scheda di fine trattamento non chiusa entro il termine, una rendicontazione non coerente si traducono in un rimborso da accordo negoziale che l'Ente non richiederà mai. Nessuno se ne accorge, perché non esiste un punto in cui i tre dati vengano confrontati sistematicamente.

Beneficio economico e di conformità. Recuperare ciò che è già dovuto

Il modulo verifica la coerenza fra il consumo registrato nei sistemi aziendali e la posizione nei registri di monitoraggio, e presidia la qualità dei flussi prima dell'invio.

- **Identificazione dei disallineamenti.** Trattamenti consumati e non registrati, chiusure non effettuate, schede incomplete, rendicontazioni non coerenti.
- **Quantificazione con termine utile.** Ogni disallineamento riporta il valore stimato del rimborso potenzialmente non richiesto e la data entro cui l'azione resta utile.
- **Lista di lavorazione ordinata per valore e per scadenza**, destinata direttamente all'operatore che compila le schede.
- **Controlli di quadratura pre-invio** sui flussi obbligatori, con segnalazione delle anomalie bloccanti prima della trasmissione.
- **Dossier pronto per i controlli.** Pacchetto documentale già riconciliato per Tavolo di monitoraggio, Corte dei Conti e verifiche regionali.
- **Indice di qualità del dato per Azienda.** Completezza e coerenza dei flussi trasmessi, che trasforma un problema tecnico in un indicatore di performance organizzativa.

Impatto quantitativo

- Attività oggi: riconciliazione File F e controlli pre-invio (24 giornate) e gestione dei registri AIFA con recupero delle schede (18 giornate), **42 giornate/anno**. È la tappa più onerosa dell'intero ciclo.
- Riduzione stimata: 45%, pari a **19 giornate/anno** liberate (133 ore). La stima è stata giudicata coerente e condivisibile in sede di revisione clinica.
- Valore economico: **60.000 €/anno**, adottato come valore prudenziale all'interno di un intervallo stimato fra **zero e 300.000 euro**. Base di calcolo: 452,7 milioni di euro di perimetro, recuperi teorici pari all'1,1% della spesa, di cui il 3% non richiesto entro il termine utile.

Perché l'intervallo è così ampio. Il valore recuperabile dipende interamente da quanto lavoro di registrazione l'Ente già svolge oggi. In una struttura che compila le schede con regolarità il recupero tende a zero, e va bene così. In una struttura che ha un arretrato il

valore sale rapidamente, perché si tratta di farmaci ad altissimo costo unitario: se l'attività di registrazione delle erogazioni nei registri AIFA non viene effettuata, l'Ente rischia il mancato rimborso di note di credito già maturate. Zero e 300.000 euro sono gli estremi realistici sul perimetro osservato. Il valore adottato, 60.000 euro, sta deliberatamente vicino all'estremo basso, e la sua verifica sul perimetro dell'Ente è uno degli obiettivi del periodo di prova.

Limite. Il modulo segnala il disallineamento. Non accede ai registri e non compila alcuna scheda in luogo dell'operatore. L'estrazione dai registri di monitoraggio è a cura dell'Ente, in forma pseudonimizzata all'origine.

Tappa 5. Confronto e chiusura

Modulo M6. Confronto fra Aziende, disponibile nella sola titolarità regionale

Fase del ciclo. L'esercizio si chiude e il risultato viene consolidato a livello regionale. È la tappa che determina se quanto è accaduto resterà un dato interno o diventerà una conoscenza utilizzabile per l'esercizio successivo.

Il problema attuale

Ogni Azienda vede solo se stessa. Il dato regionale aggregato, quando è allineato o superiore alla media nazionale, nasconde situazioni molecola per molecola profondamente diverse. Una segnalazione interna si può rinviare a tempo indeterminato, perché nulla la rende urgente. Manca il termine di paragone che trasformi una constatazione in una decisione.

Beneficio istituzionale. Trasformare una segnalazione in una decisione

Il modulo confronta la stessa molecola e lo stesso canale fra tutte le Aziende del perimetro regionale. È la funzione che il livello regionale considera più utile, e in molti casi necessaria, perché è l'unica che rende misurabile ciò che oggi si intuisce soltanto.

- **Rende visibile la variabilità organizzativa.** Se su una molecola tre Aziende su quattro hanno convertito al biosimilare e la quarta no, la differenza non è clinica. È organizzativa, ed è documentata.
- **Crea la pressione che rende l'azione inevitabile.** Un confronto regionale documentato è molto più difficile da rinviare di una segnalazione interna.
- **Benchmark dei prezzi di aggiudicazione.** Stessa molecola, stesso confezionamento, prezzi diversi fra Aziende della stessa Regione. Argomento diretto verso la centrale di committenza.
- **Simulazione di aggregazione della domanda.** Quanto varrebbe, in leva negoziale, acquistare come Regione anziché come singole Aziende.
- **Indicatore del tempo di reazione.** Il tempo che intercorre fra la disponibilità di un'opportunità e l'azione dell'Ente diventa un indicatore misurabile, confrontabile fra Aziende e verificabile da un terzo.

Impatto quantitativo

- Attività oggi: debiti informativi verso la Regione e risposte a richieste di confronto, **12 giornate/anno**.
- Riduzione stimata: 58%, pari a **7 giornate/anno** liberate (49 ore).
- Valore economico: **abilitante, non sommato.** Il modulo non genera una leva economica propria: aumenta il tasso di realizzazione delle opportunità individuate nelle tappe precedenti. Sommarlo separatamente produrrebbe un doppio conteggio.

Limite. Costruibile solo a perimetro regionale, perché richiede i dati di tutte le Aziende incluse. Nella titolarità aziendale la funzione non è disponibile, per costruzione e non per scelta commerciale.

Il ciclo si chiude qui e riparte. Quanto emerge dal confronto di fine esercizio, le molecole su cui l'Ente è in ritardo rispetto alle altre, le voci in crescita non presidiate, i recuperi non richiesti, costituisce l'input della programmazione dell'esercizio successivo, cioè della tappa 0.

3 Una leva trasversale: il confronto normalizzato per attività

Le cinque tappe descritte finora hanno una caratteristica comune, ed è anche il loro limite: lavorano tutte su farmaci ad alto costo unitario per i quali esiste, o sta per esistere, un'alternativa equivalente. È dove si concentra il valore, ma non è tutto il prontuario.

Il problema che resta scoperto. Su una categoria a costo unitario basso e volumi altissimi, senza biosimilari e senza scadenze brevettuali rilevanti, nessuna delle leve precedenti ha qualcosa da dire. Eppure è proprio lì che si annidano differenze di prezzo fra Aziende che nessuno vede, perché per vederle serve un denominatore che oggi non usiamo: **l'attività erogata**.

3.1 Che cosa cambia aggiungendo il denominatore

La normalizzazione descritta finora, euro per milligrammo ed euro per DDD, rende confrontabili due confezioni. Non rende confrontabili due Aziende: un ospedale che ricovera di più consuma di più, e sembrerà sempre peggiore. Per confrontare Aziende servono denominatori di attività, che sono tre.

Indicatore	A che domanda risponde	Fonte del denominatore
DDD per 100 giornate di degenza e accessi diurni	Si consuma più o meno degli altri, a parità di attività ospedaliera	Schede di dimissione ospedaliera
Spesa per giornata di degenza e accesso diurno	Quanto costa l'attività, indipendentemente dal volume	Schede di dimissione ospedaliera
Spesa per DDD	Si paga di più o di meno la stessa unità di terapia	Nessuno, è un rapporto interno
DDD per 1.000 abitanti die	Si tratta una quota maggiore o minore di popolazione	Popolazione pesata
Spesa pro capite	Quanto costa la categoria al sistema, per assistito	Popolazione pesata

Sono gli stessi indicatori che AIFA utilizza nei rapporti OsMed, quindi il confronto non avviene su una metrica proprietaria ma su una metrica pubblica, con la media nazionale come termine di paragone esterno.

3.2 Che cosa emerge, su dati reali

Quanto segue è il risultato dell'applicazione del metodo alla spesa per antibiotici in assistenza ospedaliera di una Regione italiana con quattro Aziende Sanitarie, sul triennio 2023-2025. I dati sono reali, riportati in forma anonimizzata.

Indicatore, esercizio 2024	Regione	Media Italia	Scarto
DDD per 100 giornate di degenza	82,2	83,4	−1,4%
Spesa per DDD	9,26 €	7,17 €	+29%
Spesa pro capite	5,65 €	3,88 €	+46%

Il primo risultato, che nessun report di spesa produce

La Regione **non consuma più antibiotici della media italiana**: a parità di attività ospedaliera è addirittura leggermente sotto. **Li paga il 29% in più.** È una diagnosi completamente diversa da quella che si otterrebbe guardando la sola spesa, e porta a un'azione completamente

diversa: non un intervento sull'appropriatezza prescrittiva, ma una rinegoziazione.

Dove si concentra il divario

Scendendo alle singole Aziende, tre su quattro stanno fra 7,36 e 7,40 euro per DDD. La quarta sta a 14,63.

Spesa per DDD	Azienda A	Azienda B	Azienda C	Azienda D
2023	5,11 €	6,57 €	**16,97 €**	9,01 €
2024	7,36 €	7,40 €	**14,63 €**	7,40 €
2025	6,65 €	6,65 €	**13,64 €**	6,74 €

Allineando ciascuna Azienda al miglior valore già ottenuto all'interno dello stesso perimetro, il divario vale **1,51 milioni di euro nel 2025**, pari al 22% dell'intera spesa antibiotica regionale.

Prezzo o appropriatezza? La scomposizione decide chi deve agire

È la domanda che determina se il problema è del clinico o del provveditore. Scomponendo l'eccedenza dell'Azienda fuori linea per classe AWaRe dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la risposta è netta.

Componente dell'eccedenza, 2024	Valore	Quota
Prezzo unitario più alto dentro la stessa classe	982.000 €	83%
Composizione fra classi, cioè maggiore uso di riserva	200.000 €	17%
Eccedenza totale rispetto alla media regionale	**1.182.000 €**	

Sugli antibiotici di riserva l'Azienda paga 87,44 euro per DDD contro 56,81 della media regionale, mentre la loro quota sul totale delle dosi è dell'11,6% contro il 10,1%, quindi appena superiore.

Detto in una riga: non prescrivono molti più antibiotici di riserva degli altri, li comprano a un prezzo molto più alto. L'interlocutore non è la Commissione Terapeutica, è l'ufficio acquisti, e l'azione non richiede alcuna decisione clinica.

Perché serve uno strumento e non un'analisi una tantum

Il divario complessivo del perimetro è passato da 3,77 milioni di euro nel 2023 a 1,69 nel 2024, poi si è fermato a 1,51 nel 2025. La parte facile è stata recuperata, il residuo è stabile da due esercizi. È il caso tipico in cui una rilevazione annuale non basta: serve qualcosa che tenga il numero visibile in modo continuo, perché ciò che resta non si corregge da solo.

3.3 Impatto quantitativo

- Attività oggi: produzione manuale della relazione di benchmark, con raccolta dei denominatori di attività, calcolo degli indicatori e costruzione delle tabelle di confronto, **20 giornate/anno**.
- Riduzione stimata: 70%, pari a **14 giornate/anno** liberate (98 ore). È la riduzione più alta di tutto il documento, perché si tratta di lavoro quasi interamente di elaborazione e non di giudizio professionale.
- Valore economico: **159.000 €/anno**. Base di calcolo: 1,51 milioni di divario rispetto al miglior valore interno, 35% contendibile nell'esercizio, attribuzione allo strumento 30%.

Perché il 35% e non di più. L'Azienda fuori linea è quella con la casistica più complessa del perimetro, e una parte del maggior ricorso agli antibiotici di riserva è clinicamente legittima. Il parametro va concordato con i clinici dell'area in fase di avvio, non imposto dallo strumento.

Che cosa richiede questa leva, e non è poco. Servono due flussi che non appartengono al perimetro farmaceutico: le schede di dimissione ospedaliera, per giornate di degenza e accessi diurni, e l'anagrafe della popolazione pesata. Nessuno dei due è oggi fra i flussi caricati. È un onere di avvio reale, va dichiarato in offerta e va verificato con l'Ente prima di impegnare la leva.

Limite invalicabile. Lo strumento riporta consumo e costo normalizzati per attività, confrontati fra strutture eroganti. Non valuta l'appropriatezza della singola prescrizione, non produce raccomandazioni terapeutiche e non associa alcun indicatore a un singolo prescrittore. La classificazione AWaRe è utilizzata come chiave di aggregazione economica, non come criterio di giudizio clinico.

4 Riepilogo dei benefici attesi

4.1 Tempo professionale

	Attività oggi svolta manualmente	Giornate oggi	Riduz.	Giornate liberate
0	Ricerca sui farmaci in arrivo, stime di impatto su richiesta	6	65%	4
1	Reportistica direzionale di spesa e analisi ad hoc	22	64%	14
2	Istruttoria dati per gare, preparazione Commissione Terapeutica	14	50%	7
3	Monitoraggio scorte, scadenze, redistribuzioni	12	50%	6
4	Riconciliazione File F, controlli pre-invio, registri AIFA	42	45%	19
5	Debiti informativi verso la Regione e richieste di confronto	12	58%	7
T	Relazione di benchmark normalizzato per attività, leva trasversale	20	70%	14
Totale		**128**	**55%**	**71**

Giornate	Ore	Valore
71	**497**	**22.365 €**
giornate / anno	ore / anno	a 45 €/h

Le 71 giornate liberate corrispondono a poco più di **tre mesi di lavoro a tempo pieno** di un dirigente farmacista, ovvero a circa il 32% di un equivalente a tempo pieno. Le stime per tappa sono state giudicate plausibili in sede di revisione clinica e restano invariate rispetto alla versione precedente, a meno della tappa eliminata.

4.2 Valore economico

	Tappa	Leva	Valore annuo
1	Programmazione	Presidio delle molecole in forte incremento	205.000 €
2	Acquisto	Anticipo della conversione dove l'equivalente entra davvero in commercio	240.000 €
2	Acquisto	Recupero della quota su originator con biosimilare già in commercio	144.000 €
4	Rendicontazione	Note di credito da registri AIFA non richieste, valore prudenziale nell'intervallo 0 a 300.000	60.000 €
T	Leva trasversale	Allineamento del costo per DDD fra Aziende, normalizzato per attività erogata	159.000 €
Totale scenario prudenziale			**808.000 €**
Totale scenario minimo, parametri dimezzati			404.000 €



La soglia di pareggio. Perché il servizio si ripaghi è sufficiente concretizzare il 13,0% dello scenario prudenziale nella configurazione regionale che comprende il benchmark per attività. Anche realizzando un solo quinto della stima, il ritorno resta superiore al canone.

4.3 Che cosa è cambiato dopo la revisione clinica

Voce	Prima	Dopo	Motivo
Anticipo della conversione post scadenza	400.000 €	240.000 €	Introdotto il fattore del 60% di ingresso effettivo di un equivalente
Sprechi di allestimento oncologico	tappa dedicata	eliminata	I laboratori UFA centralizzati sono ormai diffusi in tutte le Aziende
Capitale immobilizzato in scorte	non stimato	misurato	Riferimento operativo: 9% dell'acquistato, ovvero un dodicesimo dell'acquistato annuo
Note di credito da registri AIFA	60.000 €	60.000 €	Valore confermato, ma collocato in un intervallo dichiarato fra 0 e 300.000
Benchmark normalizzato per attività	assente	159.000 €	Leva nuova, misurata su dati reali di un perimetro a quattro Aziende
Totale	**809.000 €**	**808.000 €**	

Il totale resta quasi identico, ma è composto in modo completamente diverso. La correzione sulle scadenze brevettuali toglie 160.000 euro a una stima che assumeva un equivalente in commercio a ogni scadenza, ipotesi che un farmacista ospedaliero smonterebbe in una riunione. La nuova leva ne aggiunge 159.000, ma misurati su dati reali anziché su parametri convenzionali. La coincidenza fra i due totali è casuale e non va presentata come continuità: il valore di prima non era difendibile, questo lo è.

4.4 Che cosa non è compreso nella stima

Non sono valorizzati il risparmio da riduzione dei prodotti giunti a scadenza, la liquidità liberata dal minor capitale immobilizzato, il tempo professionale liberato dalla reportistica manuale e la riduzione del rischio di rilievo in sede di controllo. Sono benefici reali, ma si preferisce misurarli durante il periodo di verifica anziché stimarli in offerta.

5 Sintesi dell'impatto complessivo

I quattro effetti attesi

- **808.000 euro all'anno di opportunità quantificate** su un perimetro regionale di 452,7 milioni di euro, ordinate per valore, ciascuna con una finestra temporale utile e una funzione responsabile. La stima è al netto della correzione introdotta dalla revisione clinica sulle scadenze di esclusiva.
- **71 giornate/anno di tempo professionale restituite** all'attività di governo, pari a poco più di tre mesi di lavoro a tempo pieno di un dirigente farmacista.
- **Copertura dell'intero prontuario e non dei soli farmaci ad alto costo**, grazie alla normalizzazione per attività erogata, che su una singola categoria a basso costo unitario ha già evidenziato un divario del 22% fra Aziende dello stesso perimetro.
- **Da 37,7 a 40,7 milioni di euro di giacenza attesa** come termine di paragone per il capitale immobilizzato, con la misura effettiva per ciascuna Azienda.
- **Riduzione del tempo di reazione dell'organizzazione**, che è l'unico effetto che uno strumento di governance può causare in modo difendibile, ed è misurabile, concordabile in sede contrattuale e verificabile da un terzo.
- **Variabilità fra Aziende resa visibile e documentata**, nella configurazione regionale, con l'effetto di trasformare una segnalazione rinviabile in una decisione difficile da rinviare.

5.1 Le tre condizioni senza le quali nulla di tutto questo accade

1. **Lo strumento individua e quantifica opportunità. Non le realizza.** Il beneficio si concretizza solo se l'organizzazione dispone della capacità decisionale e operativa per agire sulle segnalazioni.
2. **Le opportunità quantificate devono entrare in un momento decisionale già esistente**, quale la Commissione Terapeutica o il monitoraggio periodico di budget, anziché generare un flusso informativo parallelo che nessuno presidia.
3. **Serve un referente unico della Direzione di Farmacia con mandato esplicito**, e la disponibilità dei flussi con cadenza almeno mensile e profondità storica di almeno 24 mesi.

Perché il nome. Uno strumento di navigazione non sceglie la rotta e non muove la nave: stabilisce con precisione dove ci si trova, perché chi comanda possa decidere con cognizione. VIS Pharma Compass fa esattamente questo, e nulla di più. È anche la ragione per cui la misurazione del beneficio non richiede di isolare l'effetto del software da quello dell'azione professionale, esercizio metodologicamente contestabile, ma soltanto di misurare il tempo che intercorre fra la disponibilità dell'opportunità e l'azione dell'Ente, prima e dopo l'adozione.

Ogni tappa è attivabile in autonomia,
con benefici misurabili fin dal primo esercizio.

Per chiarimenti o per pianificare il prossimo incontro, siamo a disposizione.
[Denominazione del Fornitore] · [PEC] · [Referente del progetto]